PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Ombro e coluna

Parar, modificar ou manter

Fisioterapia Esportiva e Reabilitação

NA BORDA DA PISCINA E NO CHÃO DA ACADEMIA

“Eu paro?” Uma decisão com três saídas, não com duas.

Nadadora adolescente

dor no ombro no meio da temporada

Levantador

dor lombar desde o terra de segunda

“Eu paro?”

✕ “Para tudo até passar”

tira do esporte por semanas

✕ “Continua, é normal”

mantém a carga que produziu a dor

AS TRÊS SAÍDAS

A porta do meio é a mais larga



sinal de alerta ou piora apesar de tudo

mudar o que provoca; a maior parte dos casos

dor baixa, estável, sem piora no dia seguinte

> A decisão é revista toda semana, pela leitura de 24 horas.

Esquema

QUANDO PARAR E AVALIAR

Os sinais que tiram a decisão da piscina e da academia

Ombro

- perda súbita de força depois de trauma
- sensação de que saiu do lugar
- formigamento ou fraqueza descendo para a mão

Coluna

- fraqueza ou dormência progredindo na perna
- **alteração urinária ou dormência na sela: emergência**
- dor noturna com febre, perda de peso, câncer prévio

Adolescente com dor lombar que piora ao estender a coluna

lesão por estresse do arco vertebral entra na lista: avaliação médica antes do programa

Começa numa temporada, não numa braçada

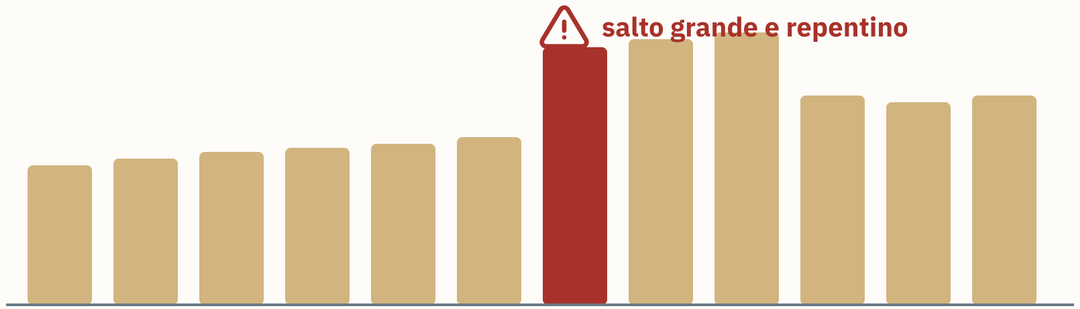
12 estudos · 1.460 nadadores

de competição, da base aos masters

base | **adolescentes** | adultos | masters

adolescentes: mais dor no ombro

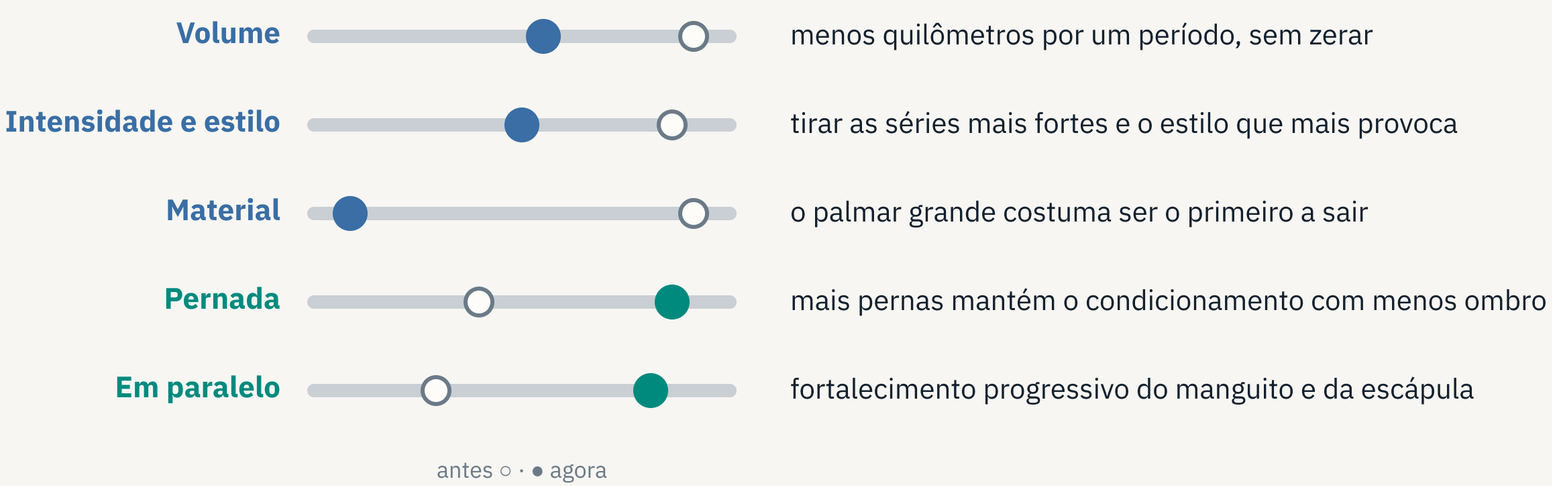
e, nesse grupo, o volume se associou à dor



Revisão sistemática, J Athl Train 2020

MODIFICAR O OMBRO

Várias alavancas, a atleta na água



> A modificação tira o pico; o fortalecimento aumenta a capacidade.

E QUANDO ALGUÉM PROPÕE CIRURGIA

Um ensaio com artroscopia sem descompressão



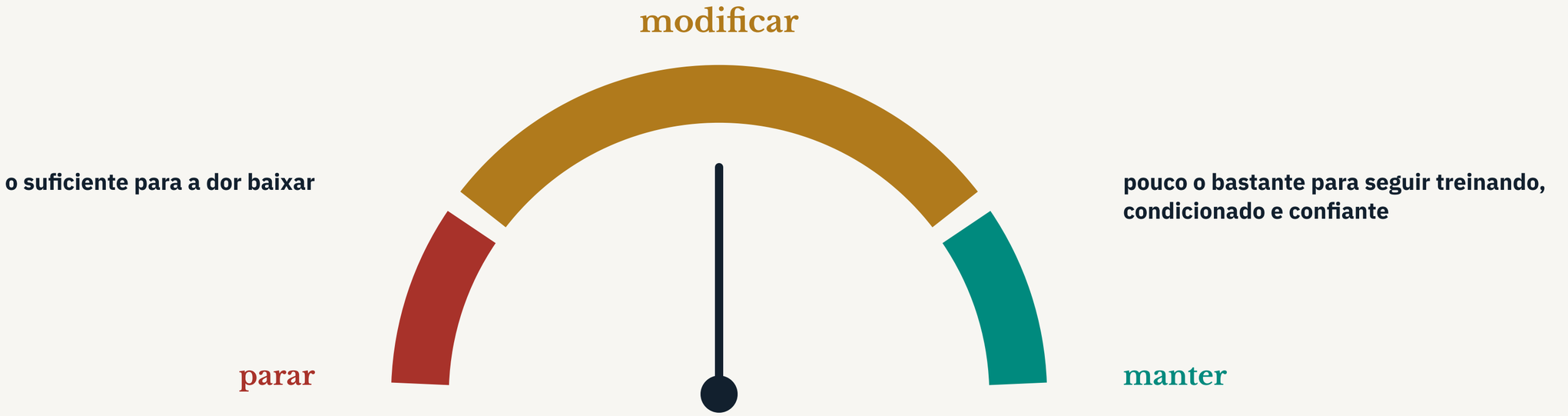
melhora da dor e da função · esquema, sem valores · diferença sem importância clínica

> Adultos com dor subacromial, não nadadores de competição; a decisão é do cirurgião com o paciente. Mas a carga bem conduzida segue como primeira linha.

32 hospitais britânicos · Lancet 2018

A IDEIA DA AULA

Parar tudo raramente é a resposta. Manter tudo também não.



“Você curvou a coluna e se machucou”

mais flexão lombar ao levantar...

? **é fator de risco para a dor começar ou persistir?** → não

? **diferencia quem tem de quem não tem dor?** → não

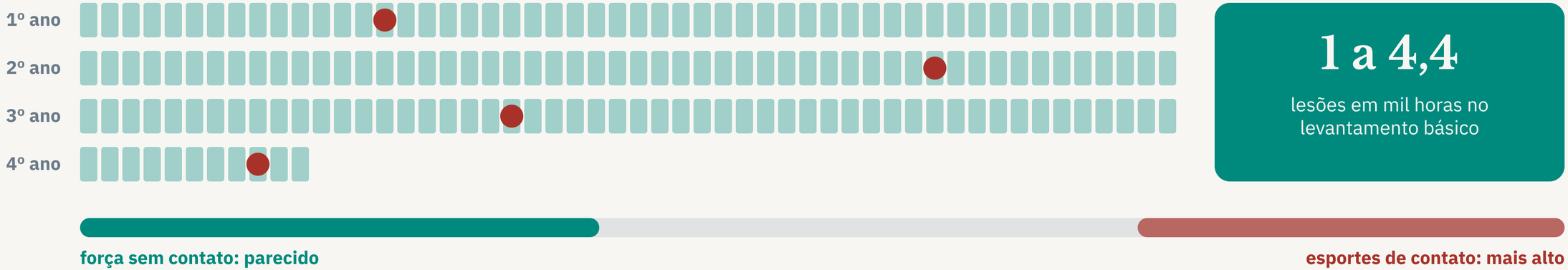
- evidência de baixa qualidade
- a técnica segue importando para o desempenho

> A explicação não tem o peso que costuma ter, e alimenta um medo de mexer a coluna que atrapalha a recuperação.

J Orthop Sports Phys Ther 2020

O medo costuma ser maior que o risco

mil horas de treino, a seis horas por semana



1 a 4,4

lesões em mil horas no levantamento básico

Revisão sistemática, Br J Sports Med 2017 · a conta dos três anos é nossa

MODIFICAR A COLUNA

Sem sinal de alerta, ele continua sendo um levantador



Carga	menos carga no exercício que provoca, sem tirá-lo; sobe pela resposta do dia seguinte
Amplitude	puxar de blocos ou suportes e ir descendo
Variação	barra hexagonal no lugar do terra; agachamento com a barra na frente
Volume	menos séries pesadas na semana
O resto	membros superiores, cardio, o que não dói: mantido

Primeira linha: educação · retomar as atividades · exercício · sem imagem de rotina

Série sobre dor lombar, Lancet 2018

O CUSTO DE ESCOLHER ERRADO

Cada erro tem o seu preço

parar	quando precisava	modificar	força, condicionamento, medo; na adolescente, a temporada
manter	quando precisava	modificar	dor crônica, volume subindo, compensação
modificar	quando precisava	parar	ruptura, lesão do arco vertebral, sinal neurológico

> Por isso a primeira pergunta é sempre a dos sinais de alerta.

OMBRO E COLUNA

A maior parte da solução está na planilha

- Primeiro, os sinais de alerta
- Depois, modificar o que provoca e manter o que não dói
- Rever toda semana pelo dia seguinte

Médico

Sinais de alerta e decisão sobre imagem.

Fisioterapia

Fortalecimento e escolha das modificações.

Treinador e preparador

Mexem no volume, na carga e no material.

Próxima aula: recursos terapêuticos; o que muda e o que é ritual.